

# 生と死 –よりよい死に方を よりよい人生を–

2年次 3組 22番 氏名 徳山 穂南

(国際福祉講座 担当：綿貫先生)

## はじめに

ターミナルケアとは、余命わずかになってしまった方へ行うケアのことで、延命処置などは行わず心のケアを中心とした看護や介護を行うことで、そのような場をホスピスという。だが、ホスピスやターミナルケアという言葉の認知度は低く、医療側からしても正しいホスピスの知識がないのが現状である。

## 問い

私自身、ホスピスという存在は知っていたが、実際どのような場所でどのようなことをしているのかを知らず、どうしてホスピスが表にでてこないか疑問に思った。

## 仮説

なんとなくいいものであるイメージを抱く人も多いが、死をタブー視する風潮が根強くホスピスなどのターミナルケアはまだまだ閉ざされているのではないか。

## ターミナルケアは閉ざされた世界…？

生きることを目指す医療の場に介入してくる死の象徴とみなされるホスピスというものは、患者の拒否感 が生まれてしまう。

→生きたいと願いながらも目の前の死を認めざるを得ないという人間性の根本的矛盾をはらみながら入院している患者にとって、その矛盾を否が応にも想起させるホスピスは歓迎されないのではないか。

## 病院での延命治療が一番大事か…？

●病院の末期患者の「悲慘な現状」

- ①過剰な延命治療
- ②苦痛の除去と症状緩和の不足
- ③患者の孤独
- ④患者の自律の欠如

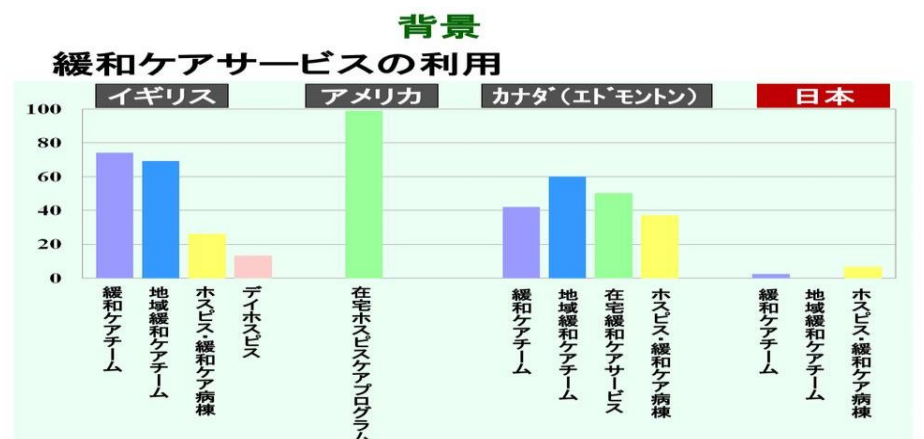
→末期患者は、すでに回復の見込みを失っているのにも関わらず、延命に重点を置いた治療が施される場合が少なくない。

延命行為は、①「機械などに囲まれ家族がゆっくり看取ることができない」  
②「本人の苦痛が長引く」として否定されるが、一時的救命が行われる場合は、②より①が優先される。

⇒患者が主役にできているか…？

## 日本はホスピスの取り組み進んでいる…？.

- 日本のホスピスの利点
  - 痛みから解放された生活を送ることができる
  - 自宅と同じように自由に生活できる
  - お酒・たばこも自由
- 日本と海外のホスピスの取り組みの差



## ホスピスが正しい生き方なのか

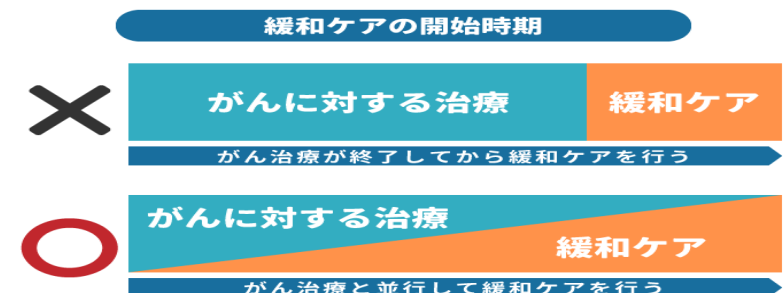
○病院とホスピスの QOL を比較する調査が行われてきたが結果的に有意差はあまり認められなかった。  
→ホスピスに行くときめた患者は病状が重く末期の患者なので QOL 調査で測った場合、一般病棟に入っている患者よりは QOL はホスピス患者の方が低いということになる。たとえ、最後の数か月に限定したとしても、患者の身体的機能を中心に見る限りでは、病院の末期がん患者とホスピスの末期がん患者との間で大差は出ないのは当然なのかもしれない。つまり、QOL 調査法の多くは末期患者に適さない。

しかし、調査が患者の満足度に限定されていたときでさえ病院よりホスピスの方が優越しているという結果が出たわけではなかった。

結局のところ、自分からホスピスに入るのを決めた患者たちはかなりホスピスに満足したのに対して、病院に決めた患者も同じように満足した。  
つまり、みんなそれぞれ自分の決断で選び決めたので、当然そのような結果になることがわかった。

## 自分の考え

ホスピスとは、新しい生き方だと私は思う。ホスピスが病院より勝っているわけではなく、双方の利点があって双方の考え方がある  
死というものを根から拒否するのではなく、死を考え、認め、そこからどう生きるのかを考える上でホスピスという新しい生き方を選択肢にいれてみてはどうか。  
よりよい死に方を考えるということは、よりよい人生を考えるのと同じことであると私は考えている。



## 参考文献

[www.arsvi.com/1990/981112ka.htm](http://www.arsvi.com/1990/981112ka.htm)  
[aroma-wet-bar.com/hospis\\_4.html](http://aroma-wet-bar.com/hospis_4.html)  
[lite.blogos.com/article/95575/?axis=&p=2](http://lite.blogos.com/article/95575/?axis=&p=2)  
<http://hokensc.jp/gam/hospice.html>